

Definition:

Zu den akuten Wunden zählen Mechanische Wunden, Thermische Wunden, iatrogene Wunden und Verletzungen durch Chemikalien. Die Wundheilung verläuft primär und sollte nach ungefähr zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein. Treten Komplikationen, wie eine Infektion auf, kann dies die Wundheilung verzögern und eine zusätzliche Therapie erfordern. Bei Wunden mit größerem Gewebsverlust tritt häufig die sekundäre Wundheilung ein. Das bedeutet, dass der Körper das verlorene Gewebe neu bilden muss, weil die Wunde nicht mit Nähten oder Klammern verschlossen werden kann. Dies kann mehrere Wochen oder Monate dauern. Auch akute und infizierte Wunden werden manchmal durch sekundäre Heilung verschlossen. Beispiele hier sind Biss- oder Abszesswunden mit hohem Infektionsrisiko.

Grundsätze:

- Wir betrachten keine Wunde als "hoffnungslos". Selbst bei Hautdefekten mit schlechter Prognose streben wir stets einen Wundverschluss an. Bleibt dieses Ziel unerreichbar, ist selbst ein kleiner Heilungsfortschritt bereits ein Erfolg.
- Jede chronische Wunde ist die Folge einer chronischen Grunderkrankung. Deren Therapie ist Voraussetzung für eine dauerhafte Wundheilung.
- Bei chronischen Wunden gibt es keine allgemeingültigen Behandlungsstrategien. Jeder Betroffene benötigt eine individuell angepasste Vorgehensweise. Wir haben keine Angst vor dem Prinzip "Versuch und Irrtum".
- Wunden sind nicht nur eine körperliche Belastung, sondern beeinträchtigen auch das Selbstwertgefühl eines Pflegebedürftigen. Niemals darf ein Bewohner den Eindruck gewinnen, dass sich die Pflegekraft vor der Wunde ekelt.

Ziele:

- Der aktuelle Wundzustand wird korrekt eingeschätzt.
- Die Lebensqualität des Bewohners bleibt soweit möglich erhalten.
- Der Bewohner ist über sein Krankheitsbild informiert. Er weiß, dass chronische Wunden eine erhebliche Gefährdung seiner Gesundheit darstellen. Er ist dazu motiviert, sein Verhalten und seine Konsumgewohnheiten so weit zu ändern, dass die Ausheilung der Wunde gefördert wird.
- Die Schmerzbelastung des Pflegebedürftigen wird minimiert.
- Komplikationen werden verhindert, insbesondere eine Wundinfektion.
- Wir erreichen einen vollständigen Wundverschluss. Im Idealfall kann auch die Bildung von übermäßigem Narbengewebe verhindert werden. Das Selbstbild des Pflegebedürftigen bleibt gewahrt.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	1	Verw./MA

- Ein Rezidiv wird verhindert. Dazu zählt auch ein erneutes Auftreten der Wunde an einer leicht veränderten Position.

Vorbereitung:

Beratung

- Wir beraten den Bewohner zu seinem Krankheitsbild. Er kann der Durchführung einzelner Pflegemaßnahmen widersprechen.
- Der Betroffene wird über die Wichtigkeit einer fotografischen Wunddokumentation informiert. Er wird um Zustimmung für die Bilderstellung gebeten.
- Wir beraten den Bewohner zum richtigen Verhalten bei bereits bestehenden Wunden. Er soll den Verband nicht selbstständig abnehmen. Überdies ist es zu vermeiden, sich in der Wundumgebung an der Haut zu kratzen.
- Basierend auf den verfügbaren Informationen erstellen wir gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen einen Behandlungsplan. Wenn sich der Bewohner wichtigen Maßnahmen zur Wundheilung widersetzt, wirken wir beständig auf ihn ein. Wir verdeutlichen ihm die Bedeutung der Wundheilung für seine Gesunderhaltung.

Allgemeines Verfahren im Haus

- Interner Wundexperte wird hinzu gezogen
- Ext. Wundexperte wird hinzu gezogen,
 - diese kommt ca. alle 2 Wochen und bei Bedarf ins Haus
 - sie erhebt die Ausmessung der Wunde und ist für Fotodokumentation verantwortlich
 - sie lässt uns Wundbericht zukommen
- wird keine Wundschwester vom HA gewünscht erfolgt die Wundausmessung und Fotodokumentation durch unsere Fachkräfte alle 2 Wochen oder bei Verschlechterung der Wunde bis zur Abheilung
- Für jede Wunde wird eine Wunddokumentation angelegt
- die Dokumentation des Verbandswchsel erfolgt auf Durchführungsnachweis
- dies wird vollständig und fortlaufend ausgefüllt
- sollte ein Verband außerhalb des normalen Intervalls erneuert werden müssen, wird dies im Berichtblatt eingetragen und begründet und dann erfolgt noch eine normale Wunddokumentation
- bei tgl. Verbandswchsel reicht eine Wundbeschreibung Mo / Mi/ Fr

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	2	Verw./MA

Wie ist eine Fotodokumentation durchzuführen?

- Es wird immer der selber Fotoapparat verwendet (jedes Team hat einen)
- Es muss immer der selbe Abstand zur Wunde eingehalten werden(Länge der Schnur des Apparates)
- Der Patient sollte immer in die gleiche Position gebracht werden

Organisation

- Eine Pflegekraft wird zur Wundbeauftragten weitergebildet. Alternativ dazu etablieren wir eine Kooperation mit einem externen Wundmanager.
 - Firma
 - Name
 - Mobil:
 - E-Mail:
- Wir stellen sicher, dass der Patient von einem Hausarzt versorgt wird. Wichtig ist auch die Bereitschaft, die notwendigen Wundaufgaben zu verschreiben, wenn der Zustand des Patienten dieses erfordert.
- Wir kooperieren auch eng mit den anderen Berufsgruppen, insbesondere mit Physiotherapeuten, mit Podologen
- Die Maßnahmen im Rahmen der Wundbehandlung sind Bestandteil der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
- Wir nutzen die Mitarbeitervisite, um Wissensdefizite unserer Mitarbeiter zeitnah zu erkennen und aufzuarbeiten.

Informationssammlung

- Die Größe der Wunde wird regelmäßig ermittelt.
- Wir nutzen die Wundfotografie, um den Entwicklungsverlauf eines Gewebedefekts abbilden zu können.
- Der Infektionsstatus der Wunde wird regelmäßig überprüft. Falls notwendig erfolgt ein Wundabstrich, um eine etwaige Keimbesiedelung einschätzen zu können.
- Im Rahmen der regelmäßigen Pflegevisiten erfragen wir, wie sehr die Lebensqualität des Pflegebedürftigen durch die chronische Wunde eingeschränkt wird.

Allgemeine Förderung der Wundheilung

- Wir stellen sicher, dass der Patient ausreichend Nährstoffe zu sich nimmt. Vor allem eine angemessene Protein- und Aminosäurenversorgung ist wichtig, damit der Körper ausreichend Binde- und Granulationsgewebe bilden kann.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	3	Verw./MA

- Im Rahmen des Möglichen werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen therapiert, vor allem eine Herzinsuffizienz.
- Die schädlichen Auswirkungen von Stoffwechselstörungen wie etwa Diabetes mellitus werden minimiert.
- Bei allen Tätigkeiten an der Wunde ist eine strikt keimfreie Vorgehensweise unverzichtbar. Dazu zählen etwa die Händehygiene, die Nutzung von Einmalhandschuhen sowie die bevorzugte Verwendung von Non-Touch-Techniken.
- Wir nutzen Wundspülungen, um Wundsekret, Gewebetrümmer oder nekrotisches Gewebe aus dem Wundgebiet zu entfernen.
- Chronische Wunden können zu einem erheblichen Juckreiz führen. Durch das Kratzen kann die Wunde jedoch verunreinigt werden. Daher versuchen wir, den Juckreiz zu lindern und den Patienten davon abzulenken.
- Wunden müssen beim Waschen vor dem Kontakt mit dem Waschwasser geschützt werden. Viele Betroffene benötigen daher Hilfe bei der Körperpflege. Wir assistieren ggf. dem Patienten bei der Ganzwaschung.
- Duschen und Bäder sind bei offenen Wunden nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt möglich. Ggf. wird die Wunde Wasser abweisend abgedeckt.
- Alkoholgenuss und rauchen behindert die Wundheilung. Der Pflegebedürftige sollte beides reduzieren oder im Idealfall einstellen.

Weitere Maßnahmen

- Bei stark nässenden Wunden erfolgt ein täglicher Wechsel der Bettwäsche. Wir vermeiden damit, dass der Geruch in die Bettwäsche übergeht.
- Insbesondere bei Hautdefekten mit sehr negativer Prognose ist es wichtig, die eigentliche Wundversorgung um Elemente der psychologischen Betreuung zu erweitern.
- Bei der Wundversorgung achten wir nicht nur auf den eigentlichen Hautdefekt, sondern auch auf die Wundumgebung. Vor allem eine Mazeration sollte vermieden werden.
- Wunden sind zumeist mit einer erheblichen Schmerzbelastung verbunden. Wir stellen daher sicher, dass der Pflegebedürftige eine angemessene Analgetikatherapie erhält.
- Im Umgang mit verwirrten Senioren ist jedoch häufig keine hinreichende Kommunikation mehr möglich. Durch eine genaue Beobachtung von Demenzpatienten schätzen wir ein, ob und in welchem Maß diese unter Wundschmerzen leiden.
- Chronische Wunden gelten als Auslöser für Depressionen und für Selbsttötungen. Wir achten daher sehr sorgfältig auf Stimmungseintrübungen und wirken im Rahmen unserer Möglichkeiten stabilisierend auf den Bewohner ein.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	4	Verw./MA

- Wundschmerzen können zur Immobilität führen. Mangelnde Bewegung wiederum steigert das Risiko für viele Komplikationen wie etwa Dekubitus, Kontrakturen oder Pneumonien. Wir intensivieren daher die entsprechenden Prophylaxemaßnahmen. Wichtig ist auch eine umfassende Deprivationsprophylaxe.
- Chronische Wunden können eine Sepsis ('Blutvergiftung') auslösen. Wir achten auf entsprechende Symptome.

Nachbereitung:

- Wenn wir eine Wunde zur Abheilung bringen, versuchen wir immer auch, die Narbenbildung so zu steuern, dass ein kosmetisch ansprechendes Gesamtbild entsteht.
- Falls es als Folge von Komplikationen zu Teilamputationen oder zu einer Defektheilung gekommen ist, rechnen wir stets mit Körperbildstörungen. Wichtig ist dann vor allem eine intensivierte zwischenmenschliche Betreuung.
- Alle Beobachtungen und Pflegemaßnahmen werden sorgfältig dokumentiert.
- Die Pflege- und Maßnahmenplanung wird an die sich verändernden Pflegeprobleme und Ressourcen angepasst.

Dokumente:

- Wunddokumentation
- Einverständniserklärung zur Fotodokumentation
- ärztliches Verordnungsblatt
- Wundbericht ext. Wundschwester
- Kommunikationsblatt mit dem Arzt

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	5	Verw./MA